

30 - Les Antidépresseurs - Pr. BENALI

(0:01 - 0:10)

Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter un cours qui s'appelle les antidépresseurs. Il s'agit d'une question d'une importance capitale.

(0:11 - 0:30)

D'abord parce que les antidépresseurs est une classe de psychotropes largement utilisée en pratique courante. Deuxièmement, leur usage a créé toute une polémique de parlement de ces dernières années. Nous avons fixé un certain nombre d'objectifs pédagogiques par rapport au cours.

(0:31 - 0:58)

Un étudiant en 5e année de médecine, un futur médecin de famille, sera capable, au terme de ce cours, de définir un antidépresseur. Il est en mesure aussi de connaître le mécanisme d'action et la classification des différentes classes d'antidépresseurs existantes. Il doit cerner les indications, les contre-indications ainsi que les effets secondaires et surtout maîtriser leur modalité de prescription.

(0:59 - 1:31)

Je porte à votre connaissance que l'évaluation de ce cours sera faite sous le mode de question à choix multiple, c'est-à-dire de QCM. Donc je vous souhaite une bonne écoute de ce cours et pour cela, j'ai établi un plan que je vais suivre pour pouvoir traiter tous les aspects inhérents à la prescription des antidépresseurs. Je vais les définir et dire brièvement les enjeux de la question.

(1:33 - 2:01)

Deuxièmement, en quatre points, je vais essayer de schématiser, de simplifier les mécanismes d'action des antidépresseurs. En troisième paragraphe, nous verrons deux types de classification les plus courantes des antidépresseurs. En quatrième chapitre, les indications sont à relater à la fois sur le plan psychiatrique et aussi les indications non psychiatriques.

(2:02 - 2:32)

Nous passerons en revue dans le cinquième paragraphe les contre-indications, puis un paragraphe sur les effets secondaires. Pour finalement discuter et s'attarder sur les modalités de prescription, en choisissant bien évidemment l'exemple de la dépression, l'état dépressif majeur. Pour définir un antidépresseur, j'ai pris ce qui a été dit il y a quelques années par Delay-Deniker.

(2:32 - 2:48)

Il s'agit d'une classe de psychotropes appartenant au thymo-analyptique. Mont-à-mot, ça signifie qu'ils remontent l'humeur. Vous avez vu que j'ai mis entre parenthèses le déprimé, c'est-à-dire qu'ils remontent l'humeur chez le déprimé.

(2:48 - 3:09)

C'est une catégorie dans laquelle ne cessent d'apparaître de nouvelles molécules. Ils ont révolutionné le traitement des états dépressifs majeurs et leurs indications tendent, comme je l'avais dit, à s'étendre en psychiatrie et dans d'autres domaines. Les enjeux de la question sont multiples.

(3:09 - 3:29)

J'en ai pris les plus pertinents. Une grande proportion de sujets souffrant de troubles mentaux et relevant de la prescription d'antidépresseurs ne sont pas traités. Pour la dépression, cela contribue aux chiffres élevés de suicides dans la population.

(3:30 - 3:55)

L'enjeu majeur par rapport à ce cours est d'améliorer le bon usage des antidépresseurs. Le deuxième paragraphe s'intéresse au mécanisme d'action des antidépresseurs. Le mécanisme d'action des antidépresseurs est tiré des hypothèses neurobiologiques liées en grande partie à la dépression.

(3:57 - 4:46)

Vous allez voir que le mécanisme d'action le plus important étant l'augmentation des concentrations de neuromédiateurs à savoir la noradrénaline, la sérotonine, dans les structures cérébrales. Cette augmentation se fera soit par réduction de la recapture neuronale présynaptique des médiateurs via des transporteurs, soit par diminution de leur dégradation enzymatique. Ceci étant illustré dans ce schéma, le blocage de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et bien évidemment à des proportions moindres de la dopamine vont augmenter les taux de ce neurotransmetteur dans la fente synaptique.

(4:46 - 5:33)

Ce qui va être à l'origine à la fois d'un effet antidépresseur et forcément d'un effet indélébile. Dans d'autres registres, on assiste à une inhibition de la dégradation des monoamines cérébrales endogènes et des monoamines ingérées qui donnera une augmentation des taux de ces monoamines au niveau cérébral et par conséquent un effet antidépresseur et quelques effets secondaires. Je rappelle dans ce diapo quelque chose de très important par rapport au rôle des systèmes monoaminergiques dans la vie courante.

(5:34 - 5:57)

La sérotonine est impliquée dans l'anxiété, l'activité motrice, l'agressivité et l'impulsivité et dans les plaques somatiques. La noradrénaline est impliquée dans la tension, la concentration, la mémoire du travail, le ralentissement psychomoteur et la fatigue. Alors que la dopamine est impliquée dans la dimension du plaisir et de la motivation.

(5:58 - 6:33)

L'ensemble de ces symptômes est en rapport avec ce que vit un patient qui souffre d'une dépression. Cela est bien relaté dans ce schéma qui montre l'interaction entre ces différents monoamines par rapport à la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Le troisième point qui semble important dans le mécanisme d'action ou les mécanismes d'action des antidépresseurs est en rapport avec un effet neurotrophique.

(6:33 - 7:16)

Un antidépresseur a un effet neurotrophique parce qu'il va favoriser l'augmentation du facteur BDNF le Brain Derived Neurotrophic Factor. Ce dernier a un rôle dans la prolifération axonale, la différenciation neuronale, la plasticité synaptique, dans la survie des neurones, dans le système nerveux central et périphérique. Il a par conséquent un facteur neuroprotecteur et neurotrophique une dimension à mon sens très importante et il joue un rôle dans la plasticité neuronale tout simplement parce qu'il va augmenter la croissance de nouveaux neurones, notamment dans l'hippocampe ce qu'on appelle la neurogenèse de l'hippocampe.

(7:19 - 7:52)

Je rappelle en dernier point qu'un antidépresseur est généralement pris par voie orale. On laisse la voie veineuse et les réserve au milieu hospitalier par rapport à une catégorie de personnes qui ont surtout une forme sévère en termes d'intensité comme la mélancolie ou il y a un risque suicidaire important. Un antidépresseur il est résorbé dans le tube digestif rapidement et il passe dans le foie pour avoir un état d'équilibre plasmatique variable entre une à quatre semaines.

(7:52 - 8:16)

Tout dépendra des antidépresseurs. Ils sont éliminés par voie rénale et ils ont une demi-vie très variable. Elle est très longue, notamment par rapport à la classe très utilisée qui est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ce qui donne un impact très important en termes de posologie et de prise puisque le patient va prendre un seul médicament par jour.

(8:19 - 9:12)

En résumé, par rapport aux paragraphes liées aux mécanismes d'action. En général, les antidépresseurs retiennent-les très bien ils restaurent la neurotransmission cérébrale soit par inhibition de la recapture présynaptique du neurotransmetteur soit par inhibition du rétrocontrôle

négligé soit par inhibition de la dégradation du neurotransmetteur en augmentant par conséquent la concentration du neuromédiateur dans la fente synaptique et ils restaurent l'activité du BDNF ce dernier a un rôle primordial dans la neurogénèse de l'hippocampe. Il y a d'autres mécanismes qui sont apparus récemment j'en ai cité un seul qui est lié à l'agonisme des récepteurs de la mélatonine à l'origine d'un médicament qui s'appelle la gomélatine on le verra plus tard.

(9:23 - 40:41)

Pour le troisième chapitre plusieurs classifications des antidépresseurs sont possibles mais aucune ne reflète vraiment les indications thérapeutiques une classification purement chimique est difficile car seule la classe des tricycliques est homogène et la classe pharmacologique des antidépresseurs reste très hétérogène tant au niveau des mécanismes d'action qu'au niveau des effets secondaires Pour faciliter la tâche aux prescripteurs on retiendra en pratique deux classifications la première dite biochimique et une deuxième dite clinique ou thérapeutique Pour la classification biochimique elle rend compte à la fois de la structure chimique du médicament de ses effets secondaires et surtout du mode d'action prévalant Cela est illustré parfaitement dans ce tableau par rapport à gauche aux différentes classes thérapeutiques qui existent et qui sont largement utilisées en pratique courante On prend le premier exemple qui est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine Le mécanisme prévalant ici étant l'inhibition de la recapture de la sérotonine il y a une large gamme qui sont les plus utilisées en pratique courante On peut citer la fluoxétine, la paroxétine la sertraline, le citalopram et les citalopram Au regard de ces noms il y a le nom commercial qui existe au Maroc et bien évidemment les doses qui varient entre la dose minimale et la dose maximale chose à retenir parce que c'est très important La deuxième classe qui s'appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline à titre d'exemple l'avant la faxine et la duloxétine En troisième lieu il y a les imipraminiques ce qu'on appelait les tricycliques qui sont les médicaments les plus anciens qui inhibent les trois monoamines à la fois qui sont la chlomipramine l'amitriptyline et l'imipramine Ils sont largement utilisés parce qu'ils ont un pouvoir très important quand il s'agit d'une dépression sévère et ils sont moins utilisés en pratique courante, on le verra pourquoi notamment par rapport aux effets secondaires Il y a les antagonistes alpha 2 qui sont la myancérine et la myrtazapine les inhibiteurs de la monoaminoxidase qui ne sont pas utilisés au Maroc mais que je cite à titre indicatif et il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure les mélatones énergiques, la gomélatine, le valdoxan qui est un nouveau médicament On avait parlé tout à l'heure à la fois de la structure chimique des effets secondaires et du mode prévalent donc on avait vu pour le premier tableau le mode prévalent c'est à dire quel est le neurotransmetteur le plus ciblé par rapport à une classe thérapeutique et ici je vous invite à voir les trois catégories d'activités qui sont à l'origine d'effets secondaires à sa fois les effets adrénergiques anticholinergiques et sérotoninergiques on le verra plus tard quels sont les effets secondaires liés à ces différentes activités pour la deuxième classification dite clinico-thérapeutique les timoanalytiques c'est à dire les antidépresseurs ont une action sur différents symptômes autre que la dépression soit l'inhibition soit l'anxiété soit un effet sédatif donc il y a une action thérapeutique autre que celle de relever l'humeur et on va

distinguer par rapport à ça trois types de médicaments ou trois classes de médicaments les sédatifs qui donnent plus de sédation les intermédiaires qui ne sont ni sédatifs ni stimulants et d'autres qui sont stimulants ou psychostimulants on va voir pour la première classe les sédatifs, ils ont une activité par rapport au sommet, par rapport à l'anxiété on citera par exemple l'amitriptyline, la maprotiline la paroxytine et la sertraline quant aux antidépresseurs intermédiaires qui n'ont pas une polarité ni sédatifs ni stimulants, ils sont au milieu et regroupent une large gamme de médicaments comme l'imipramine la chlomipramine la thianeptine ou l'ensemble des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine on dort bien évidemment de la paroxytine et la sertraline les antidépresseurs psychostimulants comme les inhibiteurs de la monoaminoxydase ou l'aminéptine il y a le bupropion qui est commercialisé au Maroc sous le nom de Welbutrin nous avons vu la définition nous avons vu les mécanismes d'action, on les a résumés et on a passé en revue les deux classifications importantes qui vont nous servir dans la prescription on arrive au quatrième chapitre qui est en rapport avec les indications des antidépresseurs on l'avait dit au départ que ces antidépresseurs remontent l'humeur chez les patients déprimés donc reprenez bien que l'une des indications principales étant les épisodes dépressifs les épisodes dépressifs regroupent l'ensemble de la pathologie dépressive ils sont indiqués dans le traitement des états dépressifs majeurs dits caractérisés d'intensité modérée à sévère et quelle que soit leur forme j'ai noté toutes les nominations qui existent dans la littérature, endogène, réactionnelle, psychogène, secondaire en tout cas, tout type d'état dépressif est susceptible d'être traité par un antidépresseur dans le cadre aussi de la dépression ces médicaments sont réservés et sont indiqués dans la prévention à la fois des rechutes ça veut dire traité au moins 6 mois à partir de la résolution des symptômes, rechutes dépressives qui est en rapport avec l'épisode lui-même ou la prévention des récurrences c'est à dire un deuxième épisode et dans ce cas il faut traiter 3 à 5 ans les sujets qui ont eu au moins 3 épisodes dépressifs en 4 ans donc si on prend les 4 dernières années d'un patient déprimé, s'il a fait 3 épisodes, on va donner les antidépresseurs pour une durée qui va de 3 à 5 ans en dehors de la dépression il y a certaines pathologies qui sont sensibles à l'action des antidépresseurs et bien évidemment sensibles à tous les aspects qu'on avait vu tout à l'heure en termes de mécanisme d'action les sérotoninergiques sont indiqués dans les troubles obsessionnels compulsifs ils sont indiqués aussi dans l'anxiété généralisée les imipraminiques et la paroxytine et le citalopram sont indiqués dans le trouble panique avec ou sans agoraphobie ça peut être aussi une indication de l'anxiété sociale on donnera les imipraminiques ou la paroxytine dans l'état de stress post-traumatique on donne les sérotoninergiques aussi bien dans les troubles des conduites alimentaires notamment la boulimie ou dans certains troubles du comportement je signale que l'aneurysme est une indication privilégiée aussi de la chlomipramine et de la mirtazapine avec le dosage que vous voyez 25 mg jour pour un poids moins de 30 kg sinon on peut aller à 50 jusqu'à 75 mg pendant 3 mois et on réévalue la mirtazapine qui est le laroxyle il peut être donné entre 10 à 20 mg surtout dans sa forme goutte entre 6 et 10 ans sinon au delà de 10 ans on donne 25 à 50 mg et là encore une fois on réévalue après 3 mois j'avais évoqué au départ qu'il y a un élargissement des indications des antidépresseurs au delà des affections non psychiatriques et

je citerai à titre d'exemple les affections neurologiques comme la lécéphalie, la migraine le syndrome parkinsonien et la narcolepsie les antidépresseurs sont très utilisés dans les algiers rebelles, tout ce qui est symptomatologie douloureuse, il s'agit aussi d'une indication privilégiée l'éjaculation précoce, on donnera les intramédiques ou les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine pour le cinquième chapitre des contre-indications j'ai essayé de vous simplifier les contre-indications toujours en classe thérapeutique en optant pour un tableau qui illustre à la fois les contre-indications absolues et les contre-indications relatives je note que pour les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine il n'y a pas de contre-indication absolue il n'y a que des précautions notamment quand il s'agit d'une femme enceinte au premier trimestre et quand il s'agit d'une insuffisance rénale ou hépatique pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline les contre-indications absolues sont l'hypertension artérielle non équilibrée la grossesse ou l'allaitement en contre-indication relative quand il y a un obstacle à l'évacuation vésicale ou en association avec la clonidine les tricycliques les médicaments les plus anciens qui sont les imipraminiques posent un certain nombre de problèmes en termes de contre-indications absolues il ne faut pas les utiliser quand il y a un glaucome angle fermé, quand il y a une hypertrophie de la prostate quand il s'agit d'une pathologie cardiaque comme l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque ou les troubles du rythme sont à proscrire chez la femme enceinte et en association avec les inhibiteurs de la monoaminoxidase ils seront utilisés avec beaucoup de précaution chez l'épileptique et chez l'insuffisance rénale et l'hépatique quand on a un patient qui a une maladie hépatique ou quand il a des convulsions il ne faut pas qu'il prenne des antagonistes alpha 2 il faut les utiliser ces derniers avec beaucoup de précaution quand il y a une hypertrophie prostatique ou une maladie cardiaque les IMAO sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 15 ans et quand il y a un état délirant ou un syndrome d'excitation, ils sont aussi à utiliser avec beaucoup de prudence quant à la femme enceinte ou la femme qui allaite et en association avec les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine après avoir résumé les contre-indications dans le tableau précédent celui-ci va vous donner une idée sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux effets indésirables vous allez voir que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont la classe des médicaments qui est utilisée avec beaucoup d'aisance pourquoi? Parce que l'ensemble des effets indésirables sont des effets transitoires et bénins on peut avoir des nausées, des constipations ou des vomissements durant les premiers jours du traitement à la longue on peut avoir une baisse de la libido ou des troubles érectiles mais tout cela est passager transitoire ce qui va vous laisser dans le futur la possibilité de les prescrire avec beaucoup de simplicité en passant à la deuxième catégorie qui inhibe à la fois la sérotonine et la noradrénaline on peut avoir des nausées on peut avoir des vertiges, des troubles sexuels des vomissements mais surtout des pics hypertensifs les imipraminiques sont à utiliser avec beaucoup de précaution parce qu'ils sont pourvoyeurs d'hypotension orthostatique ou d'hypotension d'une tachycardie dont les effets anticholinergiques vont donner une sécheresse buccale une constipation des troubles de l'accommodation une rétention urinaire et parfois des bouffées de chaleur ils peuvent être à l'origine aussi de troubles mnésiques de confusion, de céphalée, de sédation c'est la raison pour laquelle ils sont à utiliser avec beaucoup de prudence

chez le sujet âgé donc j'insiste sur ces trois catégories parce qu'ils seront les plus utilisés en pratique courante vous voyez que les antagonistes α_2 risquent de provoquer une somnolence une cédation c'est la raison pour laquelle on va les utiliser dans la dépression où il y a des troubles du sommeil et les IMAO je l'ai dit tout à l'heure qu'on ne serait pas amené à les prescrire parce qu'ils n'existent pas au Maroc nous arrivons aux modalités de prescription des antidépresseurs qui à mon sens est une partie très importante parce que elle reflète un aspect purement pratique c'est à dire si vous serez amené à prescrire un antidépresseur chez un patient chez qui vous avez diagnostiqué un état dépressif majeur quelles sont les étapes pour le choix d'un antidépresseur en prenant en considération ce qui a été fait dans le cours à savoir la classification, les effets secondaires et le profil prévalant le choix d'un antidépresseur dans l'exemple de la dépression repose sur trois étapes à retenir d'abord la tolérance et l'efficacité d'une séquence antérieure c'est à dire d'un traitement antidépresseur qui a été pris auparavant et qui a donné des résultats en termes de tolérance et en termes d'efficacité la deuxième étape étant le statut somatique du patient et le troisième point comment on va caractériser la nature de l'intensité de la symptomatologie dépressive ces trois points vont donner lieu à un choix très adéquat par rapport à notre patient si jamais le patient nous dit qu'un traitement antérieur s'est avéré efficace et toléré dans le passé il le lui sera proposé sinon dans notre pratique en première intention il faut privilégier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine parce qu'ils ont une action monoaminergique c'est à dire liée à la sérotonine en deuxième intention on prendra des médicaments à action bi-aminergique comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline une action tri-aminergique qui est en rapport avec la classe des tricycliques ou des imipramiliques donc retenez bien un traitement antérieur efficace sera proposé sinon on passe en première intention aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et en deuxième intention aux inhibiteurs recapture de la sérotonine et de la noradrénaline sinon aux imipramiliques rappelez-vous qu'un certain nombre de pathologies contre-indiquent certains médicaments antidépresseurs donc il faut veiller à ce que dans l'examen clinique on élimine un glocan par fermeture de l'ongle un obstacle prostatique une HTA ou une pathologie cardiaque il faut aussi veiller à ce que le patient ne présente pas une épilepsie il faut voir un peu l'insuffisance hépatique ou rénale, est-ce qu'elle existe demander à une femme si elle a l'aide ou si elle est enceinte et une attention particulière au sujet âgé tout simplement parce que le tableau que vous êtes en train de voir, si on a un glocan ou on a des nombres de prostates cela contre-indique bien évidemment les imipramiliques si on a une HTA, on va privilégier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine alors que les IRSN sont à utiliser avec beaucoup de prudence il faut privilégier les citaloprates et les thyroplexes en cas d'insuffisance hépatique il faut contre-indiquer la gomélatine et la duloxétine si on a une insuffisance rénale tous les antidépresseurs sont à utiliser avec des posologies adaptées au début de filtration glomérulaire en cas de grossesse ou d'allaitement il faut privilégier la sertraline et chez le sujet âgé, utiliser de préférence les antagonistes α_2 donc ce tableau facilite la tâche par rapport à un choix d'antidépresseurs pour que vous ayez une grande facilité au regard de chaque pathologie d'aller vers la classe thérapeutique à privilégier on a examiné le patient sur le plan somatique là il va

falloir caractériser sa sémiologie psychiatrique cela va se faire selon un examen et un entretien psychiatrique dans une dimension d'empathie et du climat de confiance pour enfin évaluer soigneusement l'état dépressif majeur il ne faut pas prescrire à un antidépresseur juste au regard d'un symptôme il faut que l'état dépressif majeur soit caractérisé et dans ce cas, le taux de réponse à un antidépresseur dépasse 50% il peut aller jusqu'à 65% là encore une fois j'ai opté pour le tableau tout simplement parce qu'en caractérisant la sémiologie cela donnera au regard un traitement à privilégier si on a une intensité sévère avec des idées suicidaires le patient doit être hospitalisé on mettra en place soit des imipraminides soit des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline si on a un patient qui est très anxieux, déprimé il a une anxiété marquée on va utiliser des molécules à fort potentiel anxiolytiques à savoir la paroxythine la sertraline ou certains imipraminides quand on a un trouble du sommeil prédominant on va privilégier les imipraminides sans sédatifs ou les antagonistes alpha-2 si on a une dimension d'apathie, de fatigue on va utiliser la fluoxéthyne qui est un peu stimulante et la sertraline si jamais on a un état dépressif majeur avec des plaintes douloureuses significatives on donnera la duloxéthyne qui est Psymbalta ou les imipraminides si on a une anhédonie au premier plan on va privilégier la gomélatine commercialisée sous le nom de Valdoxan au Maroc Quel est alors l'essentiel en termes de modalité de prescription ? Tous les antidépresseurs ne sont pas équivalents il faut prendre garde aux contre-indications à la nature et l'intensité des symptômes parce que ça oriente le choix d'un antidépresseur mais il ne faut pas oublier une chose importante qui est l'information du patient tout simplement parce qu'il y a nécessité d'une observance quotidienne il y a un délai d'action ça veut dire que l'efficacité est retardée dans le temps elle ne sera visible qu'à partir de la deuxième ou quatrième semaine cela semble être lié à l'augmentation du facteur neuroprotecteur le BDNF un traitement d'au moins 6 mois après la résolution des symptômes et des effets secondaires passagers et gérables notamment avec la classe la plus répandue et la plus utilisée qui est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine On arrive à une deuxième étape qui est la mise en route du traitement cela va se faire bien évidemment ce sont les doses qu'on avait vu dans le tableau on va aller progressivement avec des doses croissantes sur 5 à 1 semaine jusqu'à ce qu'on arrive à une posologie efficace, optimale c'est-à-dire la posologie qui va donner plus d'apaisement et il faut faire beaucoup d'attention au sous-dosage tout simplement parce que la dépression doit être traitée avec une dose efficace et pleine c'est la raison pour laquelle il faut revoir le patient régulièrement notamment le premier mois il faut le voir au moins 2 à 3 fois une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours si c'est possible tout simplement pour évaluer la tolérance est-ce que ce médicament est mieux toléré pour voir l'évolution des symptômes en termes d'anxiété de tristesse on avait vu que les symptômes s'apaisent à partir de la deuxième et la troisième semaine on est amené dans ces consultations à ajuster la posologie ou peut-être à co-prescrire un médicament qui va nous aider par rapport à l'anxiété en donnant des anxiolytiques par rapport aux troubles du sommeil en donnant des hypnotiques ou en privilégier pour les deux des neuroleptiques sédatifs durant ces consultations on surveille les effets indésirables il va falloir les chercher activement vous avez vu les tableaux sont très illustratifs par rapport à l'ensemble des

symptômes qui existent et surtout évaluer à chaque fois le risque suicidaire il faut dire clairement au patient est-ce que vous avez des idées suicidaires est-ce que vous pensez à la mort c'est l'occasion aussi de renforcer chez lui l'observance et être très attentif au vécu du patient par rapport à la maladie un autre point qui semble important c'est en donnant des médicaments on risque de provoquer ce qu'on appelle un virage de l'humeur notamment chez les patients bipolaires et qui passent inaperçus dans les diagnostics un virage de l'humeur étant un syndrome d'excitation marqué par une élation de l'humeur par rapport à une agitation par rapport à tout ce que vous avez vu dans le cours de la manie et l'hypomanie il faut aussi redouter ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique une question très importante à retenir et on le voit généralement quand on a un patient chez qui il y a une association de deux antidépresseurs sérotoninergiques ou d'un antidépresseur sérotoninergique avec des médicaments comme le tramadol et le lithium ce syndrome se manifeste par une confusion, une hypomanie des myoclonies, une tachycardie une diarrhée, des sueurs des frissons et parfois des hyperthermies avec une hypo ou une hypertension artérielle la conduite à tenir étant de suspendre tous les traitements de cause et prescrire des benzodiazépines un point important aussi étant le surdosage au tricyclique soit accidentellement ou quand la personne a pris énormément de médicaments en guise de suicide par exemple les symptômes sont très variables il y a des symptômes généraux comme la sécheresse buccale la tachycardie et la mydriase le patient peut présenter des troubles psychiatriques comme des vertiges, des convulsions ou des tremblements qui sont plus des troubles neurologiques des troubles du rythme et un arrêt cardiaque et surtout une détresse respiratoire qui peut aller jusqu'à le coma généralement ces patients vont être traités en milieu de réanimation et il faut généralement avant faire une intubation une assistance ventilatoire et faire un lavage gastrique si jamais il y a des convulsions il faut donner du diazepam on a prescrit un traitement et on le surveille son efficacité et sa tolérance et on se pose la question par rapport à la durée du traitement qui est une question très importante au minimum 6 mois pour un état dépressif majeur avec impérativement une phase d'attaque et une phase de conciliation la phase d'attaque est de l'ordre de 1 à 2 mois en adaptant la posologie par rapport à une réponse thérapeutique maximale l'objectif étant améliorer d'une manière satisfaisante la personne déprimée ce qu'on appelle une rémission on prend un médicament pendant une période d'attaque sur laquelle on le revoit régulièrement pour voir les effets secondaires, pour voir la tolérance mais surtout l'efficacité thérapeutique par rapport à un apaisement de la sémiologie à son amélioration satisfaisante on se dit que voilà cette personne vit une rémission complète puis on arrive à la phase de consolidation et cette phase de consolidation est en rapport avec la posologie antérieure celle qui a permis la rémission si jamais la rémission est arrivée à 40 mg on va maintenir 40 mg le but étant de prévenir les rechutes c'est à dire la réactivation symptomatique de l'épisode actuel au total on arrive au moins à 6 mois par rapport au premier épisode dépressif 12 mois pour le second et 24 mois et plus au-delà on se pose toujours la question par rapport à ces premières consultations et jusqu'à quel moment on peut dire que le traitement antidépresseur prescrit est inefficace d'abord il faut qu'on vérifie l'existence de comorbidités somatiques ou psychiatriques on vérifie si le patient prend son médicament, ce

qu'on appelle l'observance est-ce que la posologie est suffisante et il ne faut parler d'inefficacité qu'à partir de la quatrième semaine ce qu'il faut faire c'est changer un antidépresseur prescrire un antidépresseur inipramilic à dose efficace ou sinon associer deux antidépresseurs on arrive à une patient qui est traité par antidépresseur et on veut arrêter le traitement généralement l'arrêt du traitement se fait par paliers successifs sur plusieurs semaines généralement sur 6 à 8 semaines pourquoi ? parce qu'on risque d'introduire sur le patient ce qu'on appelle on le verra, un syndrome d'interruption donc il faut aller par paliers de 25% par semaine et parfois cette baisse peut être progressive et encore plus progressive si le traitement a été prolongé donc tout simplement pour éviter le syndrome de discontinuation ou d'interruption c'est un syndrome qui peut apparaître 24 heures après l'arrêt brutal d'un traitement ou lors d'une baisse graduelle il peut aller jusqu'à 10 jours la nature des symptômes est polymorphe le patient peut présenter des céphalées une léthargie, un syndrome pseudogrippale des symptômes neuropsychiatriques comme l'irritabilité de la tristesse et des idées de suicide surtout des symptômes sensoriels comme la sensation d'électricité dans le cerveau et avec des troubles visuels, accompagnés de nausées, de vomissements de diarrhées, de tremblements parfois et d'acathisie l'attitude pratique est de rassurer le patient du caractère non létal de ses symptômes et notre attitude étant soit de réintroduire l'antidépresseur avec la programmation d'une baisse graduelle bien évidemment et on peut aussi prescrire et re-prescrire des anxiolytiques, des ibuprofites ou des neuroleptiques sédatifs En dernier point et avant de conclure vous êtes amené à prescrire un antidépresseur vous avez pratiquement toutes les astuces pour pouvoir le prescrire et le maintenir dans le temps d'une manière très simple et vous serez parfois amené à demander l'avis d'un psychiatre par rapport à cette prescription cela bien évidemment est visible quand le tableau est sévère soit en termes d'intensité soit en termes de retentissement des symptômes, soit quand il y a un risque suicidaire quand le traitement est insuffisamment efficace ou mal toléré quand il y a des événements intercurrents qui apparaissent chez le patient, notamment par rapport à des idées de suicide, notamment par rapport à une symptomatologie psychiatrique autre et surtout dans la situation où le prescripteur semble être dépassé par la situation il appellera ou verra le patient chez un psychiatre en conclusion j'insiste sur le fait qu'il y a différentes classes d'antidépresseurs qui sont commercialisés il faut savoir que ce sont des médicaments capables en quelques semaines d'améliorer l'état du patient mais avec une posologie optimale et une durée suffisante une psychothérapie quelle que soit la durée la nature doit être systématiquement associée il importe d'expliquer au patient les modalités de prise de son médicament et être attentif au vécu de sa maladie l'écoute dans ce contexte est primordiale je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance merci